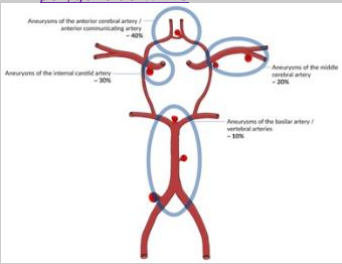


	Hématome épidural (HED)	Hématome sous-dural (HSD)	Hémorragie sous-arachnoïdienne (HSA)	Hémorragie intracérébrale (HIC)
Étiologie	Traumatique (toujours) - Saignement artériel : rupture de l'artère méningée moyenne - Saignement veineux (rare) : lésion des sinus veineux durs Non traumatique (rare) - Infections - Coagulopathies - Malformations vasculaires de la dure mère - Métastases	- Saignement veineux : rupture des veines ponts Traumatique : Aiguë via une accélération-décélération AVP +++ Syndrome du bébé secoué Traumatique ou Non : Chronique dues à l'atrophie cérébrale - Âge avancé - OH chronique - Maladies neurodégénératives - Alzheimer - Démence vasculaire - Démence VIH FR : - Antithrombotiques - Coagulopathies - MAV - Tumeur intracrânienne - HTA - Athérosclérose	Traumatique (la + courante) Non traumatique : Rupture d'anévrisme sacculaire dans le polygone de Willis  Rupture de MAV (rare) FR : - Tabac - HTA - OH - AF	Traumatique Non traumatique : Rupture secondaire à : HTA (la + courante) Angiopathie amyloïde cérébrale (+++ chez ≥ 60 ans) MAV (+++ chez enfants) - Vasculite (Horton) - Méningiome - Reperfusion post AVC - Infection SNC (Encéphalite herpétique) - Emboles septiques - Coagulopathi - Cocaïne, Amphétamines
Caractéristiques	Perte de conscience initial, immédiate Récupération et intervalle lucide Réapparition des déficits neurologiques focaux et des signes d'augmentation de la PIC	Signes d'ICP élevée : - Céphalées, vomissements Triade de Cushing - Respiration irrégulière - Pression pulsée augmentée - Bradycardie Altération de l'état de conscience Intervalle lucide (40% des cas)	Traumatique Céphalée sentinelle isolée qq j/sem. 25-50% Céphalée aiguë, inhabituelle, focale	- Céphalées (irritation méningée par le sang, d'une traction méningée et/ou d'une augmentation de la PIC) Déficits neurologiques focaux - Nausées, vomissements - Confusion et Perte de conscience - Bradycardie - Pupilles non-réactives
CT-scan natif	Peut traverser la ligne médiane Limiter par les sutures crâniennes - Lésion hyperdense biconvexe (+/- fracture) 	Peut pas croiser la ligne médiane Peut dépasser les sutures crâniennes Aiguë : Lésion extra-axiale hyperdense concave (croissant)  Chronique : Lésion hypodense 	Traumatique : Lésions hyperdenses localisés (p.ex, dans les sillons) Non traumatique : 	Traumatique : - Multiples Hématomes intra-parenchymateux - Multiples Contusions hémorragiques Non traumatique : Lésion hyperdense solitaire entourée d'un œdème hypodense - Le plus souvent dans les ganglions de la base ou la capsule interne 
Prise en charge	Mesures neuroprotectrices : O2, VNI, Normoglycémie, Normothermie - Stops anticoagulants et antiplaquettaires - Diminuer la PIC Nicardipine Labétalol			
	Craniotomie urgente (éventuellement trépanation initiale) - Évacuation de l'hématome - Réparation des traumatismes	PEC médical souvent suffisant chez les TCC léger ou petite HSA isolée Chirurgie possible : - Évacuation de l'hématome - Réparation endovasculaire d'un anévrisme - Prévention ischémie cérébrale : - Nimodipine per os - Shunt ventriculo-péritonéal - Prophylaxie TVP		Chirurgie possible : - Évacuation de l'hématome par : Craniotomie - Réparation endovasculaire d'un anévrisme